Tratamiento paliativo en el paciente con dolor oncológico

Dolor crónico: dolor oncológico

tech

CONTENIDO

1. Objetivo

2. Introducción

3. Conceptos

4. Tratamiento del dolor en cuidados paliativos

Tratamiento farmacológico en cuidados paliativos
Tratamiento intervencionista en cuidados paliativos
Medidas no farmacológicas para el dolor en cuidados paliativos

5. Conclusiones

6. Bibliografía

Objetivo

Comprender de tratamiento paliativo en el paciente con dolor oncológico.

Introducción

En la Antigua Grecia (siglos IV y V antes de Cristo) la tradición hipocrática no recomendaba el trato con enfermos incurables y/o terminales. Esto era debido a que el padecimiento de este tipo de enfermedades era interpretado como un castigo impuesto por los dioses a los seres mortales. Cualquier tipo de trato significaría entonces un desafío a la pena impuesta por las divinidades (1).

En un texto del libro hipocrático "Sobre el arte" ya puede vislumbrarse un claro rechazo a lo que hoy se reconoce, desde el movimiento hospice, los cuidados paliativos y la bioética, como encarnizamiento terapéutico (1):

> *"la medicina tiene por objeto librar a los enfermos de sus dolencias, aliviar los accesos graves de las enfermedades, y abstenerse de tratar a aquellos que ya están dominados por la enfermedad".*

Esta abstención al tratamiento fútil se basaba en una distinción entre dos tipos de enfermedades: las tiquéticas, o producidas al azar, y las ananquéticas, o de mortalidad inevitable. Las primeras podían ser tratadas mediante el "arte médico", mientras que el tratamiento de las segundas, además de ser inútil, podía significar una ofensa hacia los dioses o un pecado contra la naturaleza (1).

En la medicina hipocrática, por ende, no existe ninguna asistencia específica destinada a los moribundos. Esto va a ser modificado con el influjo de la cultura cristiana, la cual será legalizada por el emperador Constantino en el año 313 a través del Edicto de Milán (1).

El primer registro de la palabra latina *hospitium* (*xenodochium* en su versión griega) se utilizaba para designar el "sentimiento cálido experimentado por huésped y anfitrión", más tarde fue usado para nombrar a los espacios físicos en los cuales esa sensación era experimentada (dando lugar a las palabras hospicio y hospital) (1, 2).

A partir del siglo IV comienzan a aparecer las primeras instituciones cristianas, inspiradas en los principios de la caridad evangélica, que llevaron este nombre. Primero en territorio bizantino, luego en Roma y finalmente por toda Europa (1).

El término «hospice» se acuñó en la Europa del siglo XI (alrededor del año 1065) y hacía referencia a una estancia o albergue en donde se proporcionaba refugio, alimento y descanso a viajeros o peregrinos cansados, exhaustos o enfermos, y que por lo general habían recorrido grandes distancias (2).

En el siglo XIX, se presentan epidemias que diezman la población europea (tuberculosis, cólera, difteria, sarampión). De tal forma que, alejándose de los viajeros y acercándose a los moribundos, en Francia nace el hospicio de L'Association des Dames du Calvaire en 1842-1843, será entonces cuando la palabra hospice va a ser utilizada por primera vez para designar específicamente el cuidado de personas moribundas (1, 2).

La orden de las «Hermanas de la Caridad de Irlanda» en 1879 abre el hospicio de «Nuestra Señora» en Dublín, dando atención a miles de enfermos con cáncer y tuberculosis (2).

Esta última orden religiosa tuvo gran peso en la atención de las personas moribundas, atendiendo a cerca de 20 mil personas en casi un siglo (2). Mientras que el enfoque religioso de los hospicios del siglo XIV al XIX se encuadró al aspecto espiritual, el siglo XX se centralizó en la preservación de la vida a ultranza sin importar la calidad de la misma (2).

Alfred Worcester en 1935 publica su obra *The care of the Aged, the Dying and the Dead* y puntualiza la necesidad de abordar el final de la vida en forma humana y basada en la evidencia (2).

Saunders, con más de 187 referencias publicadas entre 1959 y 1967, logra delinear un modelo de hospicio diferente. Su publicación más relevante, *The management of patients in terminal state,* se convirtió en insignia de la medicina paliativa de la época. En 1967, el Hospicio «*Saint Christopher*» abre sus puertas bajo su dirección, convirtiéndose en un modelo de referencia sobre cuidados de los enfermos al final de la vida (2).

Rápidamente, se difundió este modelo en centros hospitalarios de otros países del orbe, adaptando este formato a sus realidades, y creando nuevos modelos de atención con variantes y propuestas diversas, entre ellos se encuentran (2):

- Consultorías
- Sistemas de atención a domicilio
- Centros de referencia y contra-referencia
- Centros de formación de recursos para la salud
- Centros de investigación

Los cuidados paliativos constituyen un planteamiento que mejora la calidad de vida de los pacientes (adultos y niños) y sus allegados cuando afrontan problemas inherentes a una enfermedad potencialmente mortal. Previenen y alivian el sufrimiento a través de la identificación temprana, la evaluación y el tratamiento correctos del dolor y otros problemas, sean estos de orden físico, psicosocial o espiritual (3).

Son los cuidados apropiados para el paciente con una enfermedad terminal, crónica, degenerativa e irreversible, donde el control del dolor y otros síntomas, requieren, además del apoyo médico, social y espiritual, de apoyo psicológico y familiar, durante la enfermedad y el duelo (3).

El objetivo de los cuidados paliativos es lograr la mejor calidad de vida posible para el paciente y su familia. La medicina paliativa afirma la vida y considera el morir como un proceso normal (3).

Los elementos fundamentales son (3):

1. Presencia de una enfermedad avanzada, progresiva, incurable.
2. Falta de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico.
3. Presencia de numerosos problemas o síntomas intensos, múltiples, multifactoriales y cambiantes.
4. Gran impacto emocional en paciente, familia y equipo terapéutico, muy relacionado con la presencia, explícita o no, de la muerte.
5. Pronóstico de vida limitado.

El dolor afecta de manera importante la calidad de vida y la autonomía física de los pacientes con cáncer. Está presente en todas las etapas de la enfermedad, particularmente en estados avanzados, su prevalencia es de 60 % a 100 %. Este síntoma se acompaña de sufrimiento y afecta la esfera emocional y espiritual del ser humano (4).

Desde décadas pasadas, la Organización Mundial de Salud (OMS) presenta el alivio del dolor en el cáncer y en la enfermedad terminal como un problema relevante de la Salud Pública, que sigue siendo descuidado en casi todos los países del mundo (4).

Disímiles han sido las propuestas hechas por esta organización a fin de corregir las insuficiencias en la atención a estos pacientes. Al considerar que la incidencia de cáncer sigue en aumento, el dolor no controlado pude resultar en un problema de salud pública, incluso con repercusión global (4).

Los cuidados paliativos han mostrado ser una estrategia eficaz para mejorar tanto la calidad de vida de los pacientes con cáncer como la de sus familias. A través de un acompañamiento activo durante la trayectoria de la enfermedad, es posible realizar prevención y una adecuada evaluación y control de los diferentes síntomas físicos y psicosociales (5).

Los pacientes que reciben atención por equipos de cuidados paliativos presentan disminución en el número de visitas a servicios de urgencias, menos ingresos hospitalarios y mejor control sintomático (5).

Se ha identificado que brindar cuidados paliativos en la enfermedad oncológica avanzada en los últimos dos, tres o seis meses de vida repercute de forma positiva en la calidad de vida del paciente y reduce la agresividad terapéutica al final de la vida (ingreso en unidades de cuidados intensivos, continuidad de quimioterapia en estadios finales de la enfermedad, no remisión a hospice) (5).

En relación con esto, el cuidado paliativo precoz ha sido definido como aquel en el que el tiempo transcurrido entre la primera atención por el equipo de cuidados paliativos y la fecha de fallecimiento es mayor a tres meses (5). La Asociación América de Oncología Clínica (ASCOs, por sus siglas en inglés) publicó en 2016 una guía de práctica clínica que incluyó los cuidados paliativos dentro de la atención estándar de cáncer (5).

En dicha guía recomienda que los pacientes que presentan enfermedad oncológica avanzada reciban tratamiento de un equipo de cuidados paliativos para garantizar un adecuado control sintomático, educación sobre la enfermedad y el pronóstico, un plan claro de tratamiento, preparación para el abordaje de necesidades de afrontamiento, asistencia para la toma de decisiones y coordinación con otros niveles de atención (nivel de evidencia moderado) (5).

Adicionalmente, para los pacientes con diagnóstico reciente de cáncer avanzado, recomienda la inclusión temprana en cuidados paliativos, sugiriendo que se realice dentro de las ocho semanas siguientes al diagnóstico (nivel de evidencia moderada) (5).

Es importante vincular los cuidados paliativos en todas las etapas de la enfermedad para garantizar una buena atención hasta el final de la vida, promoviendo la autonomía del paciente, facilitándole el acceso a la información y a la elección sobre sus tratamientos *(figura 1)* (6).

Se estima que más 20 millones de pacientes necesitan cuidados paliativos al final de la vida. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2011, unos tres millones de pacientes recibieron cuidados paliativos, en su mayoría, fueron pacientes que viven en países de ingreso elevados, aunque el 80 % de pacientes que requieren asistencia paliativa a nivel mundial se encuentran en países de bajo y mediano ingreso (7).

Conceptos

- **Cuidados paliativos:** la Organización Mundial de la Salud (2020) define los cuidados paliativos como: "un abordaje integral que mejoran la calidad de vida de los pacientes y sus familias al atender los problemas asociados con enfermedades que amenazan la vida, a través de la prevención y el alivio del sufrimiento por medio de la identificación, la evaluación y el tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicosociales y espirituales" (8).
- **Cuidado paliativo precoz** ha sido definido como aquel en el que el tiempo transcurrido entre la primera atención por el equipo de cuidados paliativos y la fecha de fallecimiento es mayor a tres meses (5).
- **Equipo de cuidados paliativos:** en los hospitales oncológicos, existe la tendencia a formar un grupo interdisciplinario integrado por un médico oncólogo, un cirujano, un radioterapeuta, un psiquiatra, un alergólogo, enfermeras y trabajadoras sociales especializadas en cuidados paliativos (8).

  La función de estos equipos es establecer estrategias con perspectiva ética y de calidad de vida, para proporcionar asistencia integral al enfermo y su familia (8).

Por lo tanto, los cuidados paliativos se refieren al control eficiente de los síntomas de pacientes que sufren padecimientos que los llevarán a la muerte a corto plazo, generalmente en un contexto de dolor de difícil control (8).

Arévalo Vanegas *et al.*, publica una revisión sistemática en 2021 donde identifica al dolor como el principal síntoma a tratar en los pacientes en cuidados paliativos (7).

Así mismo, los enfermos terminales necesitan ser aceptados y acogidos por sus redes de apoyo social, entre los que figuran la familia, los amigos, los médicos, las enfermeras, los trabajadores sociales, etc. Se espera que estas redes de apoyo social ayuden al enfermo a solucionar una serie de trámites pendientes relacionados con asuntos económicos, jurídicos, laborales (8).

Mientras más integrales sean los cuidados paliativos que proporciona el hospital al enfermo terminal, mayor será el bienestar de éste, pues muchas veces los asuntos no resueltos causan mayor preocupación al enfermo y menor respuesta al tratamiento (8).

Tratamiento del dolor en cuidados paliativos

Para que se apliquen adecuadamente los tratamientos médicos debe existir un equipo interdisciplinario. Este equipo debe reunirse y junto con los familiares, tomar decisiones sobre los tratamientos (curaciones, cirugías) para que exista una mejor atención de los enfermos terminales (8).

El control de los síntomas del enfermo, que padece una enfermedad avanzada o se encuentra en fase terminal, debe realizarse como una "atención global". Serviría de muy poco aplicar un tratamiento farmacológico, por muy correcto que fuese, si no va acompañado de un intenso soporte emocional (9).

Tratamiento farmacológico en cuidados paliativos

Los aspectos a tener en cuenta en su uso son los siguientes (10):

- Es necesario cuantificar la intensidad del dolor. Normalmente se utiliza escalas unidimensionales (EVA): 1-4 (primer escalón); 5-6 (segundo escalón); 7-10 (tercer escalón).
- La subida de escalón es debida a fallo terapéutico con dosis plenas de un fármaco.
- No implica que, ante un dolor difícil, no se pueda subir directamente al tercer escalón.
- No asociar analgésicos del mismo escalón, excepto cuando se asocian fármacos de tercer escalón para dolor irruptivo. No utilizar analgésicos de segundo escalón en combinación con otros del tercer escalón.

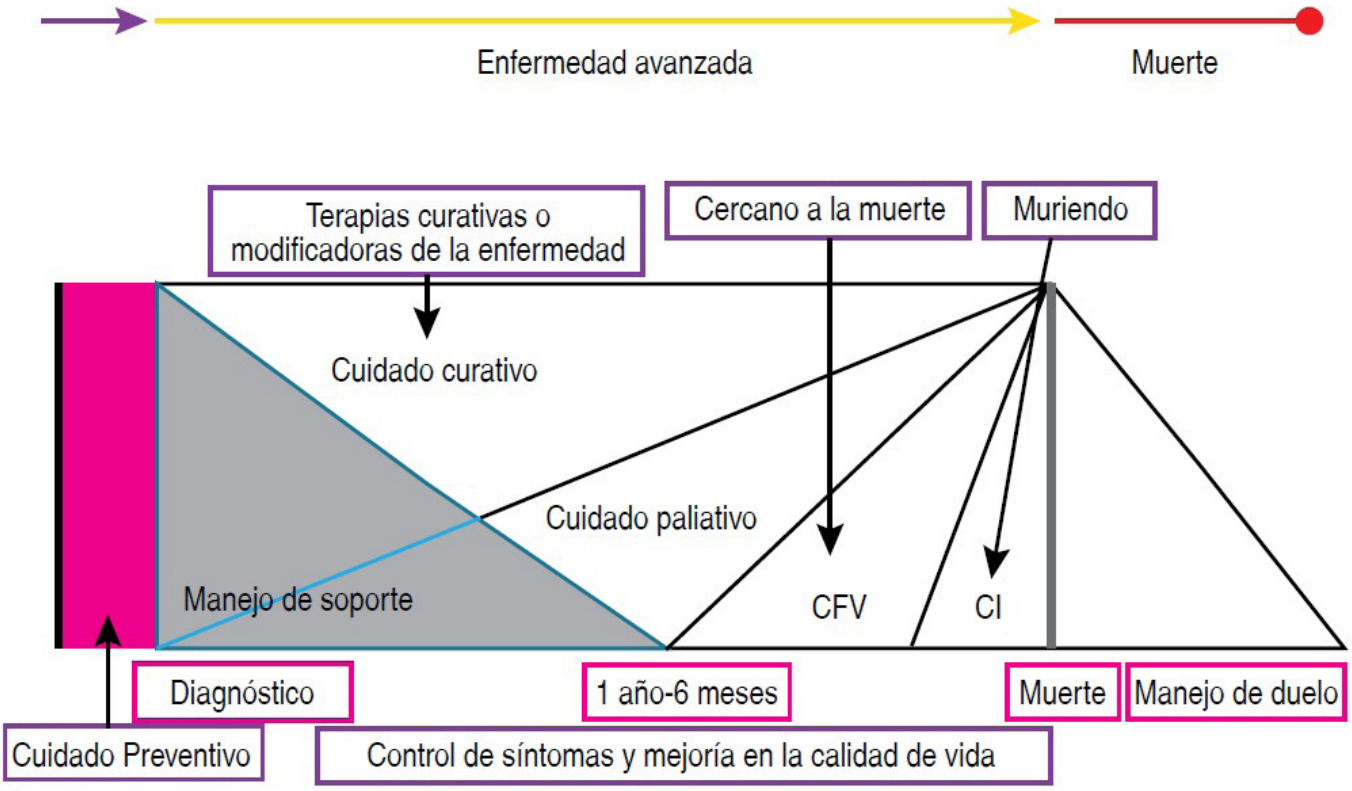

Figura 1. Vinculación de los cuidados paliativos en las etapas de la enfermedad. CFV: cuidados al final de la vida. CI: cuidado integral. Tomado de: Cuidados paliativos, ¿Cuándo referir?. https://revistasanidadmilitar.org/index.php/rsm/article/view/23.

- Los coadyuvantes se prescriben según la causa del dolor, siendo independientes de los posibles cambios de escalón terapéutico.
- Los pacientes con buen control analgésico con opioides pueden necesitar dosis de rescate, que se estima entre 1/10 y 1/6 parte de la dosis total diaria.
- Si se producen efectos secundarios severos o intolerables, se deberá cambiar el opioide. Es lo que se conoce como rotación de opioides.

Fármacos del primer escalón

Son analgésicos no opioides. Constituyen un grupo de medicamentos químicamente heterogéneos. Existe una dosis máxima diaria por encima de la cual no aportan mayor efecto analgésico (techo terapéutico) (10).

Fármacos del segundo escalón

Son los opioides débiles: codeína, dihidrocodeína, dextropropoxifeno y tramadol. Existen preparados de formulación única y simple, o en combinación fija con analgésicos antipiréticos o antiinflamatorios, y preparados de liberación retardada (10).

Fármacos del tercer escalón

Los fármacos opioides de tercer escalón (también llamados opioides potentes o mayores), se usan para tratar el dolor moderado o severo por cáncer. Los fármacos opioides más comúnmente usados: morfina, fentanilo, hidromorfona, metadona, oxicodona y tapentadol (11).

Rotación de Opioide (ROP)

La rotación de opioides se define como la sustitución de un opioide potente, previamente prescrito por un opioide potente alternativo, o cambio de vía de administración, con el objetivo específico de obtener una mejor respuesta analgésica y/o reducir una toxicidad inaceptable (11).

La incidencia de ROP varía según la causa; por mal control del dolor (15,2-64,4 %), presencia de efectos secundarios indeseables (28,8-51 %), la combinación de ambos motivos (15,4-56,8 %) o bien por otros motivos (intolerancia de la vía de administración y/o deseo del paciente) (11).

El objetivo fundamental de la ROP es conseguir el mejor equilibrio entre la analgesia y efectos secundarios. Esta práctica terapéutica se sustenta en la variabilidad individual, en la respuesta analgésica entre unos opioides y otros y en la posibilidad de tolerancia cruzada incompleta con respecto al efecto analgésico de estos (11).

Indicaciones (11)

1. Toxicidad secundaria a opioides:
   - Neurotoxicidad inducida por opioides (NIO): clínicamente se caracteriza por mioclonias, alucinaciones, delirium e hiperalgesia (dosis altas de opioides, deshidratación, insuficiencia renal, pacientes ancianos y psicofármacos favorecen su aparición).
   - Otros: náuseas, vómitos, estreñimiento y prurito.
2. Mal control del dolor: dolor mal controlado a pesar de una titulación adecuada (junto con la NIO) es una de las indicaciones principales de la ROP.
3. Alergia a opioide: es muy rara, siendo más frecuentes las reacciones de hipersensibilidad no inmunes por liberación de histamina.
4. Intolerancia a la vía de administración: reacción cutánea, problemas de adhesión y/o sudoración en preparados transdérmicos o trastornos de deglución con preparados orales.
5. Otras: motivo económico o deseo del paciente de otro opioide o vía de administración.

Dolor Irruptivo

El Dolor Irruptivo (DI) se define como una exacerbación transitoria del dolor que aparece espontáneamente o relacionada con un desencadenante concreto, predecible o impredecible, a pesar de existir un dolor basal estable y adecuadamente controlado (11).

A pesar de la existencia de numerosos estudios sobre la prevalencia del DI, con mucha variabilidad en cuanto la incidencia, actualmente se estima que el porcentaje está en torno a un 66 % (mayor frecuencia con la progresión de la enfermedad y cuando se afectan huesos de carga y plexos nerviosos (11).

El DI supone un problema significativo que puede tener un gran impacto negativo sobre la calidad de vida del paciente. Un mal control del DI comporta muchas limitaciones funcionales y se asocia a importantes repercusiones psicológicas (alteración del sueño, niveles más altos de depresión y ansiedad) además de un aumento de probabilidad de hospitalización. Es muy importante una buena identificación de este tipo de dolor y un adecuado manejo del mismo (11).

Criterios diagnósticos y características clínicas

Davies publicó un algoritmo, donde se plantean tres preguntas como criterios diagnósticos del DI: presencia de dolor basal, dolor basal controlado adecuadamente y persistencia de exacerbaciones transitorias de dolor (11).

Si las tres preguntas son afirmativas, se puede comprobar la presencia de DI. Por tanto, no pueden incluirse como DI aquellos incrementos de dolor durante la titulación de opioides de un dolor basal mal controlado, cuando no hay dolor basal controlado o simplemente cuando no hay dolor basal (11).

El DI se caracteriza principalmente por: una rápida instauración (en torno a 3-5 minutos), intensidad moderada-severa (EVA > 6-7), duración relativamente breve (media entre 15-30 minutos) y el paciente suele presentar varios episodios al día (3-4 de media) (11).

Abordaje terapéutico

Las presentaciones de citrato de fentanilo transmucoso (CFTM) han demostrado su eficacia y se consideran los fármacos que mejor se adaptan a las características del dolor irruptivo por ser analgésicos potentes, por su corta duración de efecto (1-2 horas) y por su rápido inicio de acción (en torno a 10 minutos), utilizando una vía de administración no invasiva (11).

El CFTM es el fármaco de elección para el tratamiento del DI debido a que sus características farmacocinéticas son las que mejor se adaptan al perfil y características del DI (11).

Respecto al uso de coadyuvantes en el tratamiento del dolor en pacientes con enfermedad avanzada, la evidencia muestra que, en muchas ocasiones, a pesar del uso de opioides fuertes de forma correcta por parte del paciente y de una evaluación adecuada por parte del Equipo de Cuidados Paliativos, no llega a alcanzarse un control satisfactorio, afectando de forma muy significativa a la calidad de vida del paciente y de la familia (11).

Hasta hace unos años, los fármacos coadyuvantes eran de uso obligado en el control del dolor neuropático, pero no eran usados con mucha frecuencia en el tratamiento del dolor maligno no neuropático, si se exceptúa la utilización de los corticosteroides en el dolor relacionado con la inflamación metatumoral, o el uso de bifosfonatos en el control del dolor ocasionado por las metástasis óseas (11).

Hoy, existe el consenso general de que, el uso de coadyuvantes, debe iniciarse desde el primer escalón de la Escalera Analgésica. La evidencia también muestra que, debido al componente inflamatorio que acompaña a los tumores y sus metástasis, se recomienda el uso conjunto de un opioide potente y de un Antiinflamatorio No Esteroideo (AINE) antes de añadir otros fármacos adyuvantes al tratamiento (11).

El mecanismo de acción de los fármacos coadyuvantes es diverso y, en algunos casos, producen el efecto analgésico actuando sobre varias dianas como se muestra a continuación (11):

- Reducen directamente el estímulo doloroso (11):
  - Bifosfonatos: actúan específicamente sobre las metástasis óseas
  - Relajantes de la musculatura estriada: disminuyen la contractura de la musculatura esquelética
  - Relajantes de la musculatura lisa: de uso en procesos espasmódicos biliares o de otra localización
  - Corticoesteroides: en el edema maligno.
- Reducen la sensibilización del S.N. periférico (11):
  - AINEs
  - Corticoesteroides
- Bloquean los canales del sodio (11):
  - Carbamacepina
  - Lidocaína
- Modulan los canales de calcio (11):
  - Gabapentina
  - Pregabalina
- Aumentan la inhibición de la recaptación de serotonina y noradrenalina (11):
  - Antidepresivos
- Reducen la transmisión de prostaglandinas a nivel central (11):
  - AINEs
  - Paracetamol
  - Corticoesteroides
- Reducen la sensibilización central (11):
  - Ketamina

Cuando existe un sufrimiento insoportable o cualquier otro síntoma que sea de difícil control, es vital administrar medicamentos para disminuir el nivel de conciencia y así evitar el sufrimiento y ansiedad del enfermo (8).

Tratamiento intervencionista en cuidados paliativos

Incluso con tratamientos correctos, hay pacientes en los que no es controlable el dolor (dolor intratable). En estas situaciones es cuando se deben tener presente las técnicas invasivas o técnicas del cuarto escalón (12).

Aunque las técnicas intervencionistas para el tratamiento del dolor oncológico pueden ser utilizadas en cualquier momento de la enfermedad, frecuentemente son más indicadas en estadios precoces (hasta inicio de efecto del tratamiento oncológico) y fundamentalmente en las fases finales (12).

La *(tabla 1)* recoge las indicaciones y contraindicaciones de las técnicas intervencionistas. Se debe evitar un abordaje simplista y pensar que un tratamiento farmacológico único o una terapia intervencionista aislada pueden solucionar el problema. Por ello, las técnicas intervencionistas para el tratamiento del dolor oncológico deben ser consideradas como un componente más dentro de un enfoque multimodal para el alivio del dolor (12).

Uno de los factores que más van a influir en la elección de la técnica intervencionista es la esperanza de vida del paciente. Algunas técnicas pueden proporcionar analgesia desde varios días a varias semanas. Otros, como los bloqueos neurolíticos, pueden proporcionar analgesia durante varios meses, mientras que algunos, como los dispositivos implantables de liberación de fármacos intratecales, pueden proporcionar alivio del dolor durante varios años (12).

Los procedimientos ablativos o neurodestructivos, que tienen una estrecha relación riesgo-beneficio, deben aplazarse en el tiempo, mientras que el alivio del dolor se logra con modalidades no ablativas (12).

Sin embargo, algunos procedimientos como el bloqueo del plexo celiaco en pacientes con cáncer pancreático pueden tener una relación/riesgo beneficio favorable que se garantiza con un tratamiento neurolítico precoz (12).

Técnicas quirúrgicas

La vertebroplastia consiste en la inyección en el cuerpo vertebral de una sustancia expandible que solidifica posteriormente aportando rigidez al cuerpo vertebral.

En el caso de cifoplastia, el procedimiento incluye primero la inserción de un balón para hacer un espacio que posteriormente se rellena con cemento (12). La vertebroplastia y la cifoplastia son útiles en pacientes con metástasis vertebrales, únicas o no muy numerosas (12). El beneficio es una disminución del dolor del 50-60 %, con mejoría funcional y su nivel de evidencia es 2B (12).

Indicaciones
• Dolor no controlado ni controlable • Dolor oncológico difícil • Efectos adversos severos por fármacos analgésicos • Fallo de tratamientos conservadores • Imposibilidad de la vía oral
Contraindicaciones
• Estado físico que impide realizar técnica • Coagulopatía o estado séptico severo • Infiltración tumoral del saco tecal, en caso de técnicas intratecales

Tabla 1. Indicaciones y contraindicaciones de las técnicas intervencionistas. Fuente: Guía para el abordaje interdisciplinar del dolor oncológico. Pérez Hernández 2018.

Ablación local. Indicada en dolor óseo secundario a una o muy pocas lesiones óseas oncológicas, es decir, poco volumen tumoral, tras haber intentado con radioterapia externa y no existiendo indicación de cirugía o reirradiación con radioterapia esterotáxica. La ablación local termal se puede realizar mediante distintas técnicas, siendo las más utilizadas radiofrecuencia, crioablación y ultrasonidos focales, no existiendo estudios que aporten datos con evidencia científica de sus diferencias (11).

Técnicas neuroaxiales

En la actualidad, la evidencia es de *B+* para la analgesia intraespinal (ha demostrado eficacia en ensayos clínicos controlados, pero es necesario sopesar riesgo/beneficio) y de un 2*C+* para la infusión epidural (no existen estudios clínicos controlados y sí series de casos). Ambas están recomendadas en todas las guías de dolor oncológico en pacientes refractarios (12).

En pacientes con escasa supervivencia está indicado la colocación de un *port a cath* colocado en el espacio epidural o intratecal y conectarlo a una bomba externa electrónica o un elastómero (12). En pacientes con supervivencia mayor de cuatro a seis meses está indicada la implantación de una bomba programable electrónica interna (12).

Bloqueo neurolítico

El bloqueo neurolítico consiste en la destrucción de forma temporal o transitoria de la transmisión nerviosa de las fibras de los nervios con diferentes sustancias, entre ellas alcohol y fenol. Debe limitarse a aquellos pacientes con una corta expectativa de vida, pues el efecto del bloqueo tiene una duración de tres a seis meses (13, 14).

Su nivel de evidencia es 2*A+* para la fenolisis del ganglio celiaco y 2*B+* para la fenolisis de los nervios esplácnicos. Por lo tanto, ambos tienen una recomendación positiva (12). La neurolisis del plexo hipogástrico tiene nivel de evidencia es 2*C+*. Por ello, es una técnica recomendada, aunque se debe valorar el riesgo/beneficio (12).

En el caso de la neurolisis del ganglio impar o de Walter no existen recomendaciones en las guías clínicas, aunque, en la práctica clínica habitual, es utilizado con frecuencia en el dolor perianal refractario por su baja tasa de complicaciones. Pacientes que no respondan pueden beneficiarse de una fenolisis del hipogástrico (12).

Neurolisis intratecal: consiste en una inyección de fenol o alcohol en las raíces dorsales seleccionadas introduciendo una aguja en el saco tecal. Es una técnica compleja que requiere entrenamiento específico, siendo útil en dolor selectivo en la pared torácica y en el dolor incoercible en silla de montar (12).

Estimulación nerviosa eléctrica medular y periférica

Consiste en el uso de estimulación eléctrica de la médula espinal. El electrodo de estimulación es conectado a un generador de impulsos. Este procedimiento puede ser colocado en pacientes con cáncer con sobrevida mayor de tres meses (15).

Ablación por radiofrecuencia: hallazgos metanalíticos de ensayos controlados aleatorios que comparan la ablación por radiofrecuencia de las ramas mediales con controles simulados informan puntuaciones de dolor más bajas para los períodos de evaluación de dos a seis meses después del procedimiento para pacientes con dolor lumbar (evidencia de categoría A1).

Medidas no farmacológicas para el dolor en cuidados paliativos (12)

Terapia física (12)

- Aplicación de frio o calor.
- Estimulación Nerviosa Eléctrica y Transcutánea (TENS).
- **Acupuntura:** indicado sobre todo en el dolor crónico.
- **Masajes:** han de ser utilizados con precaución en pacientes con metástasis óseas debido al riesgo de fracturas, y en aquellos con trombocitopenia o que estén tomando medicación anticoagulante, ya que pueden dar lugar a hematomas. Se han de evitar masajes directamente sobre tumores (por riesgo de diseminación), sobre prótesis (por posible desplazamiento), sobre trombos y tejidos dañados por la cirugía o la radioterapia.
- Movilizaciones activas o pasivas (12).

Terapia psicológica (12)

- Terapia cognitivo conductual
- Intervención psicosocial y psicoeducativa
- Terapia de aceptación y compromiso
- Técnicas de relajación
  - Relajación muscular progresiva
  - Visualización
  - Musicoterapia
  - Distracción

Conclusiones

El control de los síntomas es lo más importante para el enfermo en fase terminal, y su familia. ¡No lo olvidemos! Ya no les preocupa su enfermedad, sino lo que esta enfermedad le hace sufrir (9).

Cuando se proponga controlar un síntoma se debe hacer desde un concepto global porque es el síntoma de una persona con su dimensión global: biológica, emocional, social y espiritual (9).

El control de síntomas en Cuidados Paliativos se puede conseguir con la combinación sistemática de un tratamiento farmacológico preciso y estudiado, unas medidas generales no farmacológicas adaptadas al enfermo y un adecuado soporte emocional (9).

Bibliografía

1. Radosta D. Reconstrucción histórica del surgimiento del moderno movimiento hospice. Scripta Ethnologica [Internet]. junio de 2019 [citado el 21 de septiembre de 2021];9–41. Disponible en: https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/123173
2. Covarrubias A, Otero M, Templos L, Soto E. Antecedentes de la medicina paliativa en México: educación continua en cuidados paliativos. Revista Mexicana de Anestesiología. 2019;42(2):122–8.
3. Rojas X, Posso A. Cumplimiento de la ley de Cuidados Paliativos, ley 1733 de 2014 en Instituciones de Salud en Pereira. el 10 de julio de 2019 [citado el 21 de septiembre de 2021]; Disponible en: http://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/17592
4. Cruz M. Consideraciones éticas para el cuidado de pacientes con dolor por cáncer en la comunidad. Rev Cubana Med Gen Integr [Internet]. 2019 [citado el 1 de septiembre de 2021];35(4):1–12. Disponible en: https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=94492
5. Erazo M, Sarmiento G, Colmenares C. Experiencia de un programa de soporte oncológico y cuidados paliativos en Colombia. j.medipa [Internet]. 2019 [citado el 1 de septiembre de 2021];26. Disponible en: http://gestormedpal.inspiranetwork.com/fichaArticulo.aspx?iarf=220688769-747237414273
6. Ramírez E. Cuidados paliativos, ¿cuándo referir? | Revista de Sanidad Militar. el 25 de noviembre de 2020 [citado el 21 de septiembre de 2021]; Disponible en: https://revistasanidadmilitar.org/index.php/rsm/article/view/23
7. Arévalo A, Cuavas M, Hoz J, Ochoa L, Bohorquez C. Identificación de necesidades de cuidados paliativos en Pacientes oncológicos: una revisión sistemática: Ciencia y Salud Virtual [Internet]. el 30 de junio de 2021 [citado el 21 de septiembre de 2021];13(1). Disponible en: http://revistas.curnvirtual.edu.co/index.php/cienciaysalud/article/view/1544

8. Vázquez N, Nasr Z. Cuidados paliativos: Apuntes de Bioética [Internet]. el 21 de julio de 2021 [citado el 21 de septiembre de 2021];4(1):66–87. Disponible en: https://revistas.usat.edu.pe/index.php/apuntes/article/view/609
9. Bátiz J. Algunas consideraciones para un control adecuado de síntomas en cuidados paliativos. Gaceta Médica de Bilbao [Internet]. el 18 de abril de 2021 [citado el 21 de septiembre de 2021];118(1):54–9. Disponible en: http://www.gacetamedicabilbao.eus/index.php/gacetamedicabilbao/article/view/835
10. Torcal M, Ventoso S. Manejo y tratamiento del dolor en cuidados paliativos. REV CLÍN MED FAM. el 22 de junio de 2020;13(3):203–11.
11. Alonso M, Ayuso A, Blanco M, Blanco L, Cuervo M, Díaz F, *et al*. I Manual de Cuidados Paliativos de Extremadura. Extremadura, España: Junta de Extremadura; 2019.
12. Pérez C, Alonso A, Ramos A, Villegas F, Virizuela J. GADO: Guía para el abordaje interdisciplinar del dolor oncológico [Internet]. Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL); 2018. Disponible en: https://www.gado.es/descargar/Guia-GADO-Interactiva.pdf
13. Jaimes J, Leotau M, Rangel G, Miranda N, García N, Rangel J. Efectividad del bloqueo neurolítico simpático abdominal en una serie de casos descriptiva en pacientes con dolor oncológico. MedUNAB [Internet]. el 29 de noviembre de 2019 [citado el 1 de septiembre de 2021];22(3):330–40. Disponible en: https://revistas.unab.edu.co/index.php/medunab/article/view/3337
14. León M, Santa J, Martínez S, Ibatá L. Recomendaciones basadas en evidencia para el manejo del dolor oncológico (revisión de la literatura). Rev Mex Anest [Internet]. el 30 de enero de 2019 [citado el 1 de septiembre de 2021];42(1):45–55. Disponible en: https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=84793
15. Bravo K, Andrade J, Álava V, Cruz A. Anestesiología: manejo invasivo del dolor agudo y crónico. Recimundo [Internet]. el 7 de noviembre de 2019 [citado el 1 de septiembre de 2021];3(3):1463–80. Disponible en: https://www.recimundo.com/index.php/es/article/view/581